

Faculté de Médecine de Monastir
Evaluation

Pathologie Médicale
Dr Syrine DAADAA

Splénomégalie
2025

Concernant la palpation de la rate dans le diagnostic de la splénomégalie :

- A. Elle se fait de préférence avec le patient en décubitus dorsal, genoux fléchis pour relâcher la paroi abdominale.
- B. La masse palpée en cas de splénomégalie est fixe et insensible à la respiration.
- C. Le bord antérieur de la rate est crénelé.
- D. La palpation doit se faire en remontant depuis la fosse iliaque gauche vers l'hypochondre gauche.
- E. Le débord splénique doit être mesuré avec un mètre ruban à partir du rebord costal sur la ligne

La mensuration d'une splénomégalie est appréciée:

A- En centimètre du rebord costal gauche

B- En travée de doigts du rebord costal

C- En centimètre de l'épine iliaque antéro-supérieure gauche

D- A partir de la dernière cote non flottante et sur la ligne médio-claviculaire

E- En combinant une percussion thoracique à une palpation abdominale

L'échographie abdominale est utile pour le dg positif d'une splénomégalie dans les situations suivantes:

A- ascite

B- sujet âgé

C- paroi abdominale tonique

D- obésité

E- enfant

L'échographie abdominale dans l'évaluation de la splénomégalie :

- A. Confirme la nature splénique d'une masse palpée.
- B. Différencie un kyste splénique d'un hématome.
- C. Visualise des signes d'hypertension portale.
- D. Considère la splénomégalie retenue si la flèche échographique est $\geq$ 15 cm.
- E. Peut être réalisée même en cas d'ascite ou d'obésité.

Une splénomégalie pourrait être en rapport avec:

A- Une hyperplasie splénique

B- Une augmentation de la séquestration des globules rouges

C- Une congestion par hypertension artérielle

D- Une infiltration tumorale

E- Un dépôt de substances ou de cellules

Les conséquences de la splénomégalie sont

- A. L'hypersplénisme
- B. La polyglobulie
- C. L'hyperplaquettose
- D. L'hémodilution
- E. L'hypertension portale d'apport

La rate a comme rôle physiologique :

- A- Destruction des globules rouges vieillis
- B- a une fonction immunitaire surtout contre les virus
- C- Elaboration d'une réponse humorale
- D- Production du complément
- E- production des monocytes

Les situations suivantes doivent rechercher à l'examen clinique une splénomégalie:

A- sensation pesanteur ou douleur de l'hypochondre droit

B- fièvre avec adénopathie chez un patient de retour de zone endémique

C- douleur hypochondre gauche suite à un AVP

D- présence d'une pancytopénie à la NFS

E – présence d'ictère et d'ascite à l'examen

Une splénomégalie peut être découverte devant

- A. Une sensation de pesanteur de l'hypochondre gauche
- B. Un examen clinique systématique de façon fortuite
- C. Une fièvre prolongée
- D. Un infarctus splénique
- E. Un vitiligo

Devant une masse de l'hypochondre gauche, la splénomégalie fait le diagnostic différentiel avec :

- A. Un gros rein gauche
- B. Une côte surnuméraire
- C. Une tumeur du côlon transverse
- D. Une hypertrophie du lobe gauche du foie
- E. Une tumeur de la tête du pancréas

En faveur d'une splénomégalie infectieuse, vous retenir :

A- Fièvre et altération de l'état générale

B- Notion de contagion

C- Syndrome inflammatoire biologique

D- Association à des adénopathies volumineuses

E- aspect nodulaire à l'imagerie abdominale

Parmi les éléments suivants, quels sont ceux en faveur d'une splénomégalie par hypertension portale :

A - Circulation collatérale abdominale

B – Ascite

C - Hépatomégalie

D - Notion d'hématémèses

E - Eruption cutanée

Au cours d'une splénomégalie infectieuse bactérienne, vous pouvez noter :

- A. Une porte d'entrée est peut être trouvée
- B. Un syndrome septicémique (fièvre + AEG)
- C. Un syndrome inflammatoire biologique franc
- D. Un état général conservé
- E. Une hépatomégalie constante

Au cours d'une splénomégalie infectieuse au cours d'une leishmaniose viscérale, vous pouvez noter :

- A. Fièvre anarchique
- B. une infection à VIH associée
- C. ictère fébrile
- D. un état général conservé
- E. Diarrhée

Une splénomégalie fébrile avec leuco-neutropénie vous évoque :

- A. Une brucellose.
- B. Une fièvre typhoïde.
- C. Une candidose viscérale.
- D. Une mononucléose infectieuse.
- E. Une rickettsiose.

En faveur d'une splénomégalie par infection virale, vous retenez :

A- circulation collatérale abdominale

B- Ascite

C-adénopathies

D-notion d'hématémèses

E-Eruption cutanée

**En faveur d'une splénomégalie par Primo-infection à HIV,
vous retenez :**

A-Splénomégalie volumineuse

B-Polyadénopathie

C- éruption cutanée

D-diarrhée prolongée

E-fièvre et sueurs nocturnes

Une splénomégalie avec adénopathies cervicales vous oriente vers :

A-Un myélome multiple.

B-Une leucémie aigue.

C-Une mononucléose infectieuse.

D-Une cirrhose hépatique.

E-Un lupus systémique

Le syndrome de Felty associe:

A- Une splénomégalie

B- Un érythème du visage

C- Une neutropénie profonde

D- Des adénopathies médiastinales

E- Une polyarthrite Rhumatoïde

La maladie de still est caractérisée par

- A. Une splénomégalie modérée
- B. Une hyperferritinémie
- C. Une baisse de la fraction glycosylée de la ferritine
- D. Une fièvre en plateau
- E. Des arthrites

La ou es situations suivantes peut/peuvent donner une SMG:

A-Anémie de Biermer

B- hémangiome splénique

C- kyste hydatique de la rate

D- Le myélome multiple

E- lymphome splénique

La fièvre Typhoïde associe :

A- Une splénomégalie

B- Une leucopénie

C- Une fièvre anarchique

D- Une sérologie de Wright positive

E- Une angine à fausse membrane

En présence d'une Splénomégalie , le diagnostic de syndrome d'activation macrophagique sera évoqué devant:

- A. un contexte de déficit immunitaire
- B. Absence de fièvre
- C. une hypertriglycéridémie
- D. des images d'hémophagocytose dans les macrophages médullaires
- E. une hypofibrinogénémie

Une splénomégalie volumineuse est retrouvée dans les situations suivantes:

- A. syndrome myeloproliférative
- B. infections virale
- C. leishmaniose
- D. maladie de surcharge
- E. septicémie bactérienne

Une splénomégalie avec adénopathies cervicales vous oriente vers :

- A. Un myélome multiple.
- B. Une leucémie aigue.
- C. Une mononucléose infectieuse.
- D. Une cirrhose hépatique.
- E. Une sarcoïdose

La confirmation d'une leishmaniose viscérale repose sur :

A. Myélogramme

B. PCR

C. Sérologie de la leishmaniose

D. Electrophorèse des protides

E. Hémogramme

Pour confirmer le diagnostic d'un kyste hydatique de la rate on demande :

- A. Sérologie hydatique
- B. Bilan hépatique
- C. Myélogramme
- D. Echographie abdominale
- E. Abdomen sans préparation

Un malade âgé de 20 ans suivi pour une maladie Bechet présente des douleurs abdominales depuis 1 mois associées une SMG , ce tableau clinique évoque:

A- septicémie

B- Leucémie Aigue

C- Leishmaniose viscérale

D- Lymphome Malin

E-syndrome de Buddchiari

Avant d'effectuer splénectomie il faut réaliser une vaccination :

A. Anti-hépatite B

B. Anti-pneumococcique

C. Anti-tétanique

D. B.C.G.

E. Anti-grippale

Devant une splénomégalie dans un contexte fébrile, on peut évoquer une ou plusieurs des pathologies suivantes:

- A. Une angine à streptocoques
- B. Un lymphome malin non hodgkinien
- C. Une endocardite infectieuse
- D. Un lupus érythémateux systémique
- E. Un syndrome de Felty

Cas clinique N° 1

Un patient de 10 ans, consulte pour fièvre, sueurs nocturnes évoluant depuis 3 mois. L'examen révèle une splénomégalie de 10 cm douloureuse avec ascite de faible abondance, une hépatomégalie (FH : 15 cm), absence d'adénopathies périphériques.

Le bilan biologique montre :

Hb : 9g/dl, VGM : 82 μm^3 , TCMH : 27 pg ; Réticulocytes : 56000/mm³, GB = 3200 /mm³, PNN = 1000/mm³, Lymphocytes = 1500/mm³, Plaquettes = 90 000/mm³ ;
CRP = 150 mg/L.

A ce stade quel diagnostic(s) évoquez-vous chez ce patient :

A- Une tuberculose des organes hématopoïétiques.

B- leishmaniose .

C- Une fièvre typhoïde.

D- Une leucémie myéloïde chronique.

E- Une mononucléose infectieuse.

La reprise de l'interrogatoire a retrouvé une notion de consommation de lait cru. Vous retenez comme diagnostic :

- a) Une tuberculose des organes hématopoïétiques.
- b) leishmaniose.
- c) Une fièvre typhoïde.
- d) Une leucémie myéloïde chronique.
- e) Une mononucléose infectieuse

Les examens complémentaires à demander pour confirmer votre diagnostic sont :

- a) IDR à la tuberculine
- b) Myélogramme avec myéloculture
- c) Ponction biopsie hépatique
- d) IRM abdominale
- e) PCR BK sur myélogramme

Cas clinique 2

- Mme S âgée de 34 ans, sans antécédents pathologiques notables, vous consulte pour des arthralgies inflammatoires évoluant depuis 6 mois
- A l'interrogatoire, elle rapportait la notion de photosensibilité et un phénomène de Raynaud.
- L'examen physique révèle une température à 38°C, des arthrites au niveau de poignet droit et de la cheville gauche ainsi qu'une tuméfaction superficielle et mobile à la respiration au niveau de l'hypochondre gauche. Le reste de l'examen était sans particularités.

- Biologie: **VS**=70 (H1) **CRP**= 6 mg/l **Creat**=60umol/l

NFS: Hb=9g/dl VGM=82 TCMH=28 Rétic=70000/mm3

- GB=3100/mm3 lymph=1100/mm3 PNN=1700/mm3 ,
plaquette: 100 000/mm3

Les caractéristiques sémiologiques de la tuméfaction de l'hypochondre gauche objectivée chez notre patiente correspondent à :

- A. Une tumeur de l'angle colique gauche
- B. Un gros rein gauche
- C. Une grosse rate
- D. Un lobe gauche du foie hypertrophié
- E. Une tumeur de la queue de pancréas

Devant ce tableau, le bilan minimal de première intention doit comprendre :

A. Bilan hépatique complet

B. Dosage des LDH

C. Bilan phospho-calcique

D. Dosage de fibrinogène

E. Groupe sanguin

Parmi ces diagnostics, quels sont les deux les plus probables:

- A. Une sarcoïdose
- B. Une tuberculose hématopoïétique
- C. Une endocardite infectieuse
- D. Une septicémie à pyogène
- E. Un lupus érythémateux systémique

Afin d'étayer le diagnostic, les examens complémentaires qu'il faut réaliser sont :

- A. Echographie abdominale
- B. Echographie cardiaque trans-thoracique
- C. AAN
- D. Sérologies VHB/VHC
- E. Bilan tuberculeux

Cas clinique 3

Une femme 63 ans est hospitalisée dans votre service pour fièvre. Depuis 15 jours elle présente une aggravation avec asthénie sévère, nausées, fièvre à 38°5 et sueurs profuses.

A l'examen vous trouvez une tachycardie à 108/mn, une TA à 105/70 mmHg, une Splénomégalie et une pâleur intense. L'auscultation pulmonaire est normale, l'auscultation cardiaque retrouve un souffle prothétique mitral. L'examen de l'abdomen est normal.

ATCD: une phlébite , ablation de 2 polypes du sigmoïde il y a 7 ans, et prothèse valvulaire mécanique mitrale il y a 5 ans sur insuffisance mitrale dystrophique sévère.

Depuis 5 mois, la patiente présente une asthénie avec perte de poids de 4 kg et troubles du transit associée à des douleurs abdominales intermittentes.

1/Quel diagnostic devez-vous évoquer en premier?

A- endocardite infectieuse

B-septicémie

C- syndrome myléoprolférative

D-infection virale

E- cancer colique

2-Quels examens demandez-vous afin de l'affirmer

A- hémoculture et échographie cardiaque

B- NFS

C- électrophorèse des protéines

D-sérologies virales

E- colonoscopie avec biopsie

Une TDM TAP à montré une SMG avec foyer d'infarctissement. Des hémocultures positif à E.Coli et à l'échographie une végétation au niveau de la valve mitrale.

Le dg d'une endocardite infectieuse était retenu quelle serait la porte d'entrée

A- dentaire

B- digestive

C-cutanée

D- pulmonaire

E- urinaire

Cas clinique 4

Mme A âgée de 32 ans consulte pour des polyarthralgies inflammatoires des grosses articulations depuis 1 mois et une fièvre évoluant depuis plus que 3 semaines. A l'examen, la température était à 38,7°C, l'auscultation cardiaque et pulmonaire étaient sans anomalies. On ne trouvait pas d'arthrite ou d'éruption cutanée. La palpation abdominale révèle une masse de l'hypocondre gauche mobile avec la respiration évoquant une splénomégalie. A la biologie, la CRP= 28mg/l, VS= 82 mm, NFS= Hb= 8,7g/dl, VGM = 72 fl, plaquettes= 220 000 elt/mm³ , GB= 3200 elt/mm³ , Lym= 1000 elt/mm³, PNN= 2200 elt/mm³

Chez cette patiente vous suspectez :

- A. Une septicémie à pyogène
- B. Une mononuléose infectieuse
- C. Une fièvre typhoïde
- D. Une brucellose
- E. Un lupus erythémateux systémique

vous allez demander les explorations suivantes :

A. Sérologie de Wright

B. Sérologie de Widal

C. AAN

D. Echographie abdominale

E. Protéinurie de 24h

L'évolution de la patiente était marquée par l'apparition de lésions ecchymotiques diffuses avec persistance d'une fièvre prolongée. Un bilan biologique fait a montré :

- NFS : Hb= 7g/dl, VGM= 70fl, plq= 30 000, GB=2000, Ly= 800, PNN= 1200
- TP= 40%, TCA= 1,5 fois le témoin, fibrinogène= 1g/l , Ferritinémie= 2000, CHT= 2g/l ; TG= 3 mmol/l

- **Vous suspectez quelle(s) complication(s) ?**

A. Leucémie aigue

B. Syndrome myélodysplasique

C. CIVD

D. Syndrome d'activation macrophagique

E. Anémie mégaloblastique